Pacient 5 r.č. 523456/5555 poj.

tel.

Vstupní onkologický protokol

Akutnost stavu: P3

Alergie: neguje

CAVE: Handicap:(zrak)

FA: Betaloc 200mg 1-0-0, Lozap H 1-0-0, Euthyrox 112ug 1-0-0, Purinol 300mg 01-0-, Omeprazol 20 mg 1-0-0, Mertenil 20 mg 0-0-1, Metformin 500mg p.o. 1-0-0, Zaldiar dlp

OA: HTN, DM II. na PAD, chron VAS L páteře, Hypothyreoza, progresivní polyartritida, stp op tumoru tlustého střeva 1999, stp borelioze

PA: SD

SA:

GA: nchodí prav 1x ročně na gyn, v pořádku,

Stagingová vyšetření:

V rámci MASC záchyt drobného okrskovitého stínu na rozhraní DKK při bazi žlázy vlevo, sonograficky oválné ložisko 8x3mm v blízkosti submamární rýhy

13.2.2026 CCB

Histologie:

Mikropopis:

a,b) V punkčních válečcích tkáň mléčné žlázy se strukturami P120 cytoplasmaticky a GATA3 jaderně pozitivního **invazivního lobulárního karcinomu,** skóre gradingu nádoru dle modifikované Notthinghamské klasifikace je 3+3+1=7, střední diferenciace, **G2.** Myoepitélie v p63 nejsou zastiženy. V PAS nález obdobný.

Imunohistochemické vyšetření:
E-CAD (DAKO, klon NCH-38).....negativní
Ki67 (Zytomed, klon SP6).....10 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2).....100 %
PR (Novocastra, klon 312/2).....0
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... HER2 negativní (skóre 0)

2,4,2026 BCS + SLN l.sin.

Velikost tumoru: 6 mm v největším průměru (měřeno mikroskopicky)
Typ nádoru: Invazivní lobulární karcinom + LCIS (viz biopsie č. 6293/2026).
Grading nádoru: G2
Angioinvaze a invaze do lymfatik: Ne
Perineurální šíření: Ne
Resekční linie: Intaktní, karcinom je od **černě barvené (kaudální) resekční plochy vzdálen méně než 1 mm**

'levý prs - lem'

Průřezy tukově vazivovým stromatem mléčné žlázy se zastižením ložiska LCIS, které je vzdáleno od černě barvené resekční plochy 16 mm. V IHC vyšetření s protilátkami p63 a CK14 se pozitivně barví myoepiteliální lemy, protilátka CKAE1/AE3 pozitivní epitelové struktury. V řezech s protilátkami E-CAD, PR a ER se struktury LCIS vykrájely. Dále zastižena apokrinní metaplázie. **Černě barvená resekční plocha je intaktní.**

Imunohistochemické vyšetření (blok):
E-CAD (DAKO, klon NCH-38)..... negativní
Ki67 (Cell Marque, klon SP6)..... 5 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2)..... 70 %
PR (Novocastra, klon 312/2)..... 0 %
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... 0 (ultralow)

SONO břicha a RTG plic - negat

z MDT 2026 Indikována adjuvantní RT a HT.Př low risk karcinomu po dohodě s pacientkou bez radioterapie

Status praesens:

subj -
, chlůze o dvou FH, doma obědy vozí, pro chor bolesti Lp moc nechodí, t.č. bez zn

Vstupní onkologický protokol

infektu
břicho - v nivae, dýchá v celém rozsahu, měkké, volně prohmatné, nebolestivé, dkk - bez otoků a varixů
st localis - vlevo prs po resekci fibrotický, palp bez hm resistemce, bradavka bpn, axiola bvez zv uzlin, LHK bez omezení s elevací,pravý prs včetně bradavky a axily bpn

Hmotnost [kg]: 94 **Výška [cm]:** 158 **BMI:** 37.65 **Plocha těla[m2]:** 1.95

PS: 2

Diagnostický souhrn:

onkoduplicita
I. r 1999 Ca c descendens ,pT3N0M0, adenoca G1
- resekce, adj CHT do 2/2022, dips do r 2013

II Ca mammae l.sin pT1b N0(0/3)M0
- 4/2026 BCS + SLN l.sin (FNO)
dnes pohovor před nasazením hormonoterapie

Plán péče:

- dnes odběry ko, zákl biochemie, CE a CA 15-3
- nasazení hormonoterapie IA ARIMIDEX tbl 1-0-0
preventivní iopatřerní osteoporsys - vápník, vit
- kontrola zsa 3.5m

Datum: **Podpis:**